

Otitis media aguda y sus complicaciones (mastoiditis, perforación timpánica)

1. Introducción y relevancia clínica

La **otitis media aguda (OMA)** es una **infección del oído medio** caracterizada por inflamación de la mucosa timpánica y acumulación de líquido purulento en la cavidad del oído medio.

Es una de las enfermedades infecciosas **más frecuentes en pediatría**, y una **causa importante de prescripción antibiótica** en atención primaria.

En Chile, según datos de MINSAL, la OMA representa cerca del **30–40% de las consultas respiratorias en menores de 5 años**, especialmente en invierno.

En adultos es menos frecuente, pero suele ser más severa y con mayor riesgo de complicaciones.

La relevancia clínica de la OMA radica en:

- Su **alta incidencia en niños**, especialmente entre los **6 meses y 3 años**.
- La posibilidad de **complicaciones graves**, como **mastoiditis, meningitis o absceso cerebral**.
- Su impacto en la **hipoacusia transitoria o permanente** si se maneja inadecuadamente.

2. Fisiopatología y bases conceptuales

La OMA se origina por una **disfunción de la trompa de Eustaquio**, que comunica la nasofaringe con el oído medio.

Cuando la trompa se obstruye (por inflamación o infección respiratoria alta), se produce **acúmulo de secreciones** y **disminución de la ventilación del oído medio**, generando un ambiente propicio para la proliferación bacteriana.

2.1 Mecanismo fisiopatológico

1. Infección respiratoria alta (rinitis, faringitis, adenoiditis).
 2. Edema y obstrucción de la trompa de Eustaquio.
 3. Retención de secreciones y presión negativa en oído medio.
 4. Colonización bacteriana (ascenso desde la nasofaringe).
 5. Inflamación purulenta con dolor, fiebre y abombamiento timpánico.
-

2.2 Microbiología

Gérmenes más frecuentes (OMS / MINSAL):

Agente	Frecuencia aproximada	Comentario
<i>Streptococcus pneumoniae</i>	30–40%	Más común en niños <2 años
<i>Haemophilus influenzae</i> (no tipificable)	25–30%	Asociado a recurrencias
<i>Moraxella catarrhalis</i>	10–15%	Causa leve, autolimitada
<i>Streptococcus pyogenes</i> y <i>S. aureus</i>	<5%	Formas graves o complicadas
Virus respiratorios (VRS, influenza, adenovirus)	Coinfección frecuente	Predisponen a sobreinfección bacteriana

2.3 Factores de riesgo

- Edad <3 años.

- Asistencia a jardín infantil.
- Infecciones respiratorias recurrentes.
- Exposición al humo del tabaco.
- Alimentación con mamadera en posición horizontal.
- Reflujo gastroesofágico.
- Hipertrofia adenoidea.
- Labio leporino o fisura palatina.

3. Clínica (signos, síntomas y diagnóstico diferencial)

3.1 Síntomas característicos

Síntoma	Característica
Otalgia	Aguda, continua, pulsátil. Empeora con la deglución o decúbito.
Fiebre	Habitual, a menudo >38 °C.
Hipoacusia conductiva	Por líquido o pus en oído medio.
Otorrea	Si existe perforación timpánica.
Irritabilidad o llanto nocturno	En lactantes.
Síntomas de vía aérea alta	Congestión nasal, tos, rinorrea.

3.2 Signos clínicos (otoscopía)

Hallazgos clásicos:

- **Membrana timpánica abombada**, opaca, eritematosa.
- **Disminución de la movilidad timpánica** (otoscopía neumática).
- **Nivel hidroaéreo** visible o burbujas.
- **Perforación timpánica** con salida de pus (otitis media supurada).

Evolución clínica:

1. **Inicio catarral** (1–2 días): congestión nasal, fiebre, otalgia leve.
2. **Fase supurada** (2–3 días): dolor intenso, abombamiento timpánico, fiebre alta.
3. **Perforación espontánea**: alivio del dolor, aparición de otorrea.
4. **Resolución** en 7–10 días con tratamiento adecuado.

3.3 Diagnóstico diferencial

Diagnóstico	Diferencias principales
Otitis externa	Dolor al mover el pabellón o presionar el trago, tímpano íntegro
Otitis media serosa (secretora)	Sin fiebre, tímpano retraído con nivel líquido claro
Sinusitis aguda	Dolor facial, congestión nasal sin otalgia significativa
Mastoiditis	Dolor retroauricular, abombamiento y desplazamiento del pabellón

4. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

Diagnóstico clínico (según guías MINSAL y AAP)

Se requieren tres criterios:

1. **Inicio agudo de síntomas.**
2. **Signos de efusión en oído medio** (abombamiento, nivel líquido, movilidad disminuida).
3. **Signos de inflamación** (eritema, otalgia, fiebre).

Exámenes complementarios

Examen	Indicación	Comentario
Timpanometría	Si duda diagnóstica	Detecta líquido o presión negativa
Cultivo de otorrea	En otitis con perforación o fracaso terapéutico	Permite ajustar antibiótico
TAC de peñasco	Solo si sospecha de complicaciones (mastoiditis, absceso)	Evalúa erosión ósea o extensión
Hemograma / PCR	En cuadros graves o tóxicos	Evalúa inflamación sistémica

5. Tratamiento (según guías MINSAL / Chile)

5.1 Manejo general

- Control del **dolor y fiebre**:

- **Paracetamol o ibuprofeno** según peso.
- Analgesia tópica con lidocaína en gotas puede ser útil (si tímpano íntegro).
- **Hidratación adecuada.**

5.2 Conducta antibiótica

El tratamiento depende de la edad, severidad y factores de riesgo.

Grupo	Conducta recomendada	Antibiótico de elección
Niños <6 meses	Tratar siempre	Amoxicilina 80–90 mg/kg/día VO en 2 dosis por 7–10 días
6–24 meses con fiebre u otalgia intensa	Tratar	Igual esquema
>2 años, síntomas leves	Observación 48–72 h; tratar si no mejora	Amoxicilina 80–90 mg/kg/día
Fracaso o recurrencia	Amoxicilina + ácido clavulánico	90 mg/kg/día (amoxicilina)
Alergia a penicilinas	Cefuroxima o azitromicina	Según tolerancia

5.3 Duración del tratamiento

- Niños <2 años o casos severos: **10 días**.
 - Niños mayores con síntomas leves: **5–7 días**.
-

5.4 Indicaciones especiales

- **Perforación timpánica o supuración:**
→ Añadir **ciprofloxacino ótico** (3 gotas cada 8 h por 7 días).
 - **Otitis recurrente (>3 episodios en 6 meses):**
→ Evaluar hipertrofia adenoidea y derivar a ORL.
 - **Alergia grave a penicilina:**
→ Azitromicina 10 mg/kg/día por 5 días.
-

6. Complicaciones y pronóstico

6.1 Complicaciones agudas

Complicación	Manifestaciones clínicas	Manejo
Mastoiditis aguda	Dolor retroauricular, eritema, abombamiento y desplazamiento del pabellón	Hospitalizar, antibióticos EV (ceftriaxona + cloxacilina), posible cirugía (mastoidectomía)
Perforación timpánica	Otorrea purulenta, alivio del dolor	Gotas antibióticas, control ORL; cierre espontáneo habitual
Parálisis facial	Compresión inflamatoria del VII par	Corticoides + antibióticos
Labirintitis	Vértigo intenso y nistagmo	Hospitalización
Meningitis / absceso cerebral	Fiebre persistente, signos neurológicos	Emergencia vital

6.2 Complicaciones crónicas

- Otitis media crónica supurada.
- Colesteatoma adquirido.
- Hipoacusia conductiva permanente.

Pronóstico:

Excelente con tratamiento precoz.

Las secuelas auditivas permanentes son raras si no hay complicaciones.

7. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM

Perlas clínicas

1. OMA = otalgia + fiebre + tímpano abombado y opaco.
 2. La **amoxicilina alta dosis (80–90 mg/kg/día)** es el estándar inicial en Chile.
 3. En **>2 años con síntomas leves**, puede optarse por **observación vigilada 48–72 h**.
 4. Si aparece **otorrea**, significa **perforación timpánica**: usar antibiótico ótico.
 5. En niños con **OMA recurrente**, descartar **hipertrofia adenoidea o reflujo**.
 6. **Mastoiditis** = dolor retroauricular y pabellón desplazado → **derivar urgente**.
-

Errores comunes

- Diagnosticar OMA sin visualizar tímpano.
- Usar dosis bajas de amoxicilina (ineficaz contra neumococo).
- No indicar analgésicos o control del dolor.
- Suspender antibiótico antes de tiempo.

- No controlar a las 48 h si hay fiebre persistente.
 - No derivar mastoiditis a especialista.
-

8. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. La **otitis media aguda (OMA)** es una infección del oído medio causada principalmente por *S. pneumoniae* y *H. influenzae*.
2. Se diagnostica por **inicio agudo + tímpano abombado o con efusión + signos inflamatorios**.
3. El **tratamiento de elección** es **amoxicilina 80–90 mg/kg/día VO**.
4. La **observación sin antibióticos** es válida en >2 años con síntomas leves.
5. **Mastoiditis y perforación timpánica** son las complicaciones más relevantes.
6. El **control del dolor y fiebre** es parte esencial del manejo.
7. Derivar a ORL en casos **recurrentes o complicados**.